EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 78099
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 29-01-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ANA ESTER RETAMAL LARA			RUN	: 4.214.700-1
F.Nac	: 05-07-1939	Edad	: 84 AÑOS, 6 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: GAONA S/N			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA D	Teléfono	: 979963062		
Fecha Ingreso	: 2024-01-27	Fecha Egreso	: 29-01-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Epicrisis Medicina Interna

Diagnosticos:
-Neumonia Comunitaria
-Insuficiencia Respiratoria Resuelta
-Artritis Reumatoide
-Hipertension ARterial.

Farmacos
-Prednisona 10mg x dia
-ElcalD 1 al dia
-Omeprazol 20mg
-NO refiere tomar antihipertensivos.

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Cuadro clinico hace 1 semana aproximadamente caracterizado por tos seca, fatiga, sensacion de disnea y compromiso del estado general, por persistir sintomas es traida a este centro el dia de ayer donde valoran en SU HSC solicitan laboratorios destacando en Hemograma Leucocitosis con neutrofilia PCR elevada (320mg) , sedimento orina patologico y GSA con hipoxemia .

Angiotac torax Sin TEP , Neumonia bibasal.

Se hospitaliza en medicina y se inicia manejo con ceftriaxona + azitromicina + broncodilatacion + corticoides sistemicos y Kinesioterapia.
A las 24 horas se logra destete de oxigeno.

Laboratorio:
PCR 320 --- Luego 221 / Crea 0.7 / Na 139 / K 3.6 / CL 108
GB 10500 / PL 213000 / HB 11.3
Ph 7.45 / Po2 91 amb / HCO3 17.9
Orina inflamatoria: UC + Klebsiella Pneumoniae NO BLEE.
CSB candada (no se trata) - Kazachstania telluris (responde clinicamente bien a ceftriaxona)

Evoluciona favorablemente.
Al dia 29.1.2024 cumple 24 horas sin oxigeno , sin apremio ventilatorio , sin fiebre y con hemodinamia estable.
Mantiene necesidades de broncodilatacion y kinesioterapia respiratoria por lo que se solicita continuar manejo por equipo de Hodom.

INDICACIONES AL ALTA

1. Indicaciones:
2. -Regimen Liviano.
3. -Reposo Relativo.
4. -Ceftriaxona 2g ev al dia (3/7)
5. -Azitromicina 500mg vo al dia (3/5)
6. -Ipratropio 4 puff cada 6 horas
7. -Prednisona 10mg vo al dia. (mantener tratamiento crónico)
8. -Omeprazol 20mg vo al dia.
9. -Metamizol 1 comprimido cada 8 horas por 5 dias.
10. -Paracetamol 1g vo cada 8 horas por 5 dias
11. -Tramadol 8 gotas SOS , dolor.
12. -Kinesioterapia respiratoria segun categorizacion.
13. -Rescatar antibiograma de CSB y eventual ajuste Antibiotico.
14. -Luego de ser dad de alta de cuadro actual, retomar tratamiento crónico y debe ser enviada por conducto regular a evaluacion por ARtritis Reumatoide desde su Cesfam.
15. -Control en Urgencias SOS.

Control en: 7 días en CONSULTORIO DE ORIGEN

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE
16178692-6

JEFE SERVICIO